

MOTOR DE REGLAS DIAGNÓSTICAS — Hoja técnica (no editar)

Esta hoja calcula automáticamente el diagnóstico presuntivo a partir de los datos del FORMULARIO_INGRESO

DIAGNÓSTICO	CIE-10	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	ALERTAS CLAVE
Cefalea tensional	G44.2	Dolor holocraneano / bilateral / opresivo	EVA 1–6 · no pulsátil	Sin náuseas ni vómitos	Excluir migraña si hay náuseas + foto + fonofobia
Migraña sin aura	G43.0	Dolor unilateral pulsátil · EVA ≥6	Náuseas y/o vómitos presentes	Fotofobia Y fonofobia juntas	Imagen urgente si es 'peor cefalea de la vida'
Infección respiratoria alta viral (IRA)	J00/J06	Rinorrea + congestión nasal + tos	Fiebre ≤38.5 °C o afebril	Mclsaac ≤1	SpO ₂ <94% → sospechar neumonía
Faringoamigdalitis (SGA posible)	J02/J03	Mclsaac ≥3: fiebre>38+exudado amigdalino	Ausencia de tos	Adenopatías cervicales dolorosas	Trismus + uvúla desviada → absceso urgente
Gastritis / dispepsia funcional	K29/K30	Dolor/ardor epigástrico · relación con comidas	Plenitud posprandial / saciedad temprana	Alivio con antiácidos	Hematemesis o melenas → URGENTE
Gastroenteritis / colitis aguda	K52/A09	Diarrea ≥3 deposiciones/24h	Náuseas y/o vómitos + inicio agudo	Dolor cólico abdominal	FC>100+mucosas secas → rehidratación urgente
Infección urinaria baja (cistitis)	N30	Disuria + polaquiuria + urgencia miccional	≥2 síntomas SIN flujo vaginal → >90% ITU	Turbidez/mal olor en orina	Fiebre+dolor lumbar → pielonefritis urgente
Lumbalgia mecánica aguda	M54.5	Dolor lumbar bajo sin irradiación >rodilla	Mejora con reposo · empeora con movimiento	Sin déficit neurológico	Fiebre+lumbalgia o incontinencia → derivar
Trastorno de ansiedad (GAD)	F41	GAD-2 ≥3 (sensibilidad 89%)	Nerviosismo / preocupación excesiva ≥2 semanas	Sin causa orgánica evidente	Crisis de pánico: inicio súbito+palpitaciones+disnea
Depresión — tamizaje positivo	F32	PHQ-2 ≥3 (sensibilidad 79%)	Anhedonia + tristeza ≥2 semanas	Pérdida de energía / concentración	PHQ-2≥3 → preguntar ideación suicida
Vaginositis / vulvovaginitis	N76	Flujo vaginal anormal (color/olor)	Picazón o ardor vulvovaginal	Sin síntomas urinarios predominantes	Fiebre + dolor pélvico → EIP · derivar
Conjuntivitis aguda	H10	Enrojecimiento ocular + secreción	Sensación de arenilla / lagrimeo	Sin dolor ocular profundo	Dolor profundo+fotofobia+visión borrosa → Oftalmología
Amenorrea / alteración menstrual	N91	Ausencia de menstruación >45 días	Descartar embarazo (pregunta directa)	Antecedente de anticonceptivos o estrés	Test embarazo antes de cualquier medicación
Hemorragia vaginal anormal	N93	Sangrado fuera del ciclo o excesivo	Sin relación clara con menstruación	Puede asociarse a dolor pélvico	Sangrado abundante + inestabilidad → URGENTE

CALCULADORA INTERACTIVA — Score Mclsaac (Faringoamigdalitis)			
Fiebre > 38 °C	0	0 = No · 1 = Sí	
Ausencia de tos	0	0 = Tiene tos · 1 = No tiene tos	
Exudado o hipertrofia amigdalina	0	0 = No · 1 = Sí	
Adenopatías cervicales anteriores dolorosas	0	0 = No · 1 = Sí	
Edad 15–44: 0 pts / <15 años: +1 / ≥45 años: -1	0	Ingrese: -1, 0, o 1	
PUNTAJE TOTAL Mclsaac	0	Bajo riesgo SGA → Manejo viral	

TABLA DE REFERENCIA — PHQ-2 y GAD-2 (evidencia 2024–2025)					
ESCALA	PUNTAJE	INTERPRETACIÓN	SENSIBILIDAD	ESPECIFICIDAD	ACCIÓN
PHQ-2	0–2	Bajo riesgo depresión	79–82%	88–90%	Sin acción inmediata
PHQ-2	3–4	Riesgo moderado	79–82%	88–90%	Aplicar PHQ-9 completo
PHQ-2	5–6	Alto riesgo depresión	79–82%	88–90%	Protocolo crisis + ideación suicida
GAD-2	0–2	Bajo riesgo ansiedad	89%	91%	Sin acción inmediata
GAD-2	3–4	Riesgo moderado ansiedad	89%	91%	Ampliar con GAD-7
GAD-2	5–6	Alto riesgo ansiedad	89%	91%	Evaluación psicológica urgente

COMBINACIONES DE RIESGO ELEVADO — Alertas automáticas	
Paciente diabético + PA sistólica <90 mmHg	Hipoglucemia posible → tomar glucemia capilar de INMEDIATO
Paciente hipertenso + cefalea severa (EVA≥8)	Crisis hipertensiva posible → verificar PA, notificar médico
Paciente asmático + SpO ₂ <95%	Crisis asmática → broncodilatador y evaluación urgente
Mujer embarazada + PA sistólica ≥140 mmHg	Preeclampsia posible → atención médica inmediata
PHQ-2 ≥3 + respuesta 'Sí' a ideación de daño	Protocolo de crisis de salud mental → notificar médico ya